

児童・青年期精神医学

令和8年4月7日

名古屋市立大学大学院医学研究科

こころの発達診療研究センター センター長

こころの発達医学寄附講座 教授

山田 敦朗

神経発達症群（発達障害）



- ◆ 発達期に発症する一群の疾患。典型的には発達期早期、しばしば小中学校入学前に明らかとなり、個人的、社会的、学業または職業における機能の障害を引き起こす発達の欠陥により特徴づけられる。
- ◆ 知的発達症、コミュニケーション症、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、限局性学習症、運動症が含まれる。
- ◆ しばしば他の疾患に併発する。（例：自閉スペクトラム症と知的発達症、注意欠如・多動症と限局性学習症）

神経発達症は重なり合う



自閉スペクトラム症

注意欠如・多動症



限局性学習症

発達性協調運動症



自閉スペクトラム症



自閉スペクトラム症の一例



5歳年長男子。出生時は特に異常なかったが、1歳半健診で言葉が出ておらず、指差しができず視線が合わずフォローアップ教室に通った。2歳になってもまったく喋らないため、児童精神科を受診し自閉症と診断された。言語訓練に通い、年少は母子で療育に通った。バイバイも年少になっ
てするようになったが手を逆に向けてする。とってほしいものがあると大人の手をつかんでとらせようとする。年中から加配の先生つきで保育園に入園した。

自閉スペクトラム症の一例

年中になると単語は喋れるようになったが、名前を聞くとオウム返しになってしまう。発達全体が遅めで、トイレも自分ではできない。ままごとなどで遊ぶことはなくミニカーを並べる遊びが好きでずっと一列に並べる。止めるとパニックを起こして床に頭を打ち付ける。偏食が目立ち、ヨーグルトなど決まったメーカーの物しか食べない。今でも他の子と遊ぼうとしない。夜はなかなか寝ずいつまでも起きているのに朝は早く起きる。小学校は特別支援学級で入学を考えている。

自閉スペクトラム症の有病率の変化

1万人当たりの有病率

Wingら 1979 自閉症 4.9 自閉スペクトラム症 21.2 0-15歳

杉山ら 1989 自閉症 13.0 1.5歳

本田ら 2005 自閉症 27.2 9～10歳

CDC (Centers for Disease Control and Prevention)

2007 自閉スペクトラム症 106 8歳

2014 自閉スペクトラム症 168 8歳

土屋賢治ら 自閉症・自閉症スペクトラム障がいの疫学研究の動向 脳と精神の医学 第20巻 第4号 2009年

Baio J et al. Prevalence of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years - Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2014. MMWR Surveill Summ. 2018 Apr 27;67(6):1-23

神経発達症の割合

文部科学省が平成24年, 令和4年に実施した「通常の学級に在籍する発達障がいの可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」の結果では、約6.5パーセント程度の割合で通常の学級に在籍している可能性を示している。

	平成24年	令和4年
学習面又は行動面で著しい困難を示す	6.5%	8.8%
学習面で著しい困難を示す	4.5%	6.5%
行動面で著しい困難を示す	3.6%	4.7%
学習面と行動面ともに著しい困難を示す	1.6%	2.3%

平成24年度: http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1328729.htm

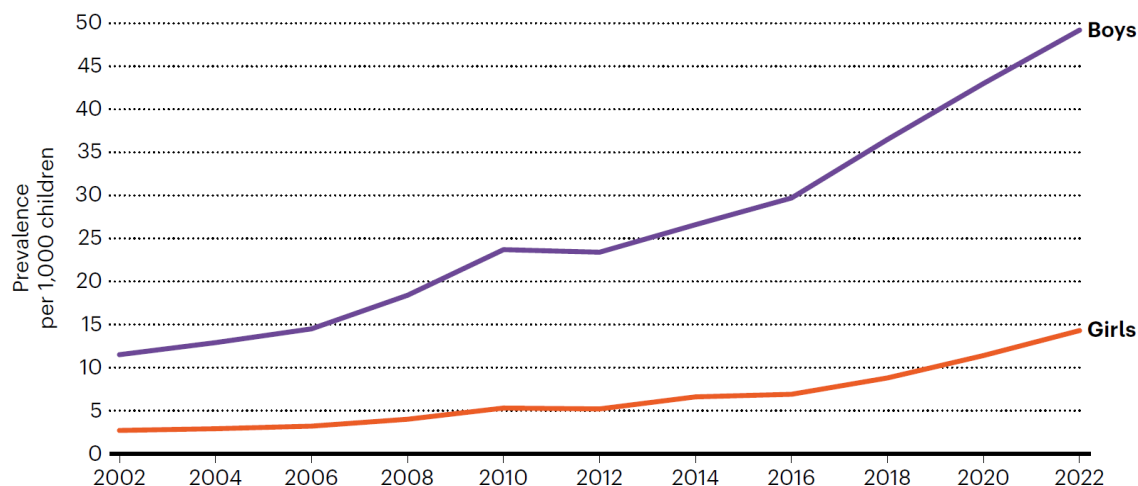
令和4年度: https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2022/1421569_00005.htm



WHAT'S REALLY DRIVING THE RISE IN AUTISM?

TALLYING AUTISM DIAGNOSES

Reported autism prevalence has more than doubled in US boys and girls since 2010, according to data from the Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, which draws on health and education records.



自閉スペクトラム症の有病率

✓ 診断基準の変化

- 子どもの疾患から全ライフステージの疾患へ
- 支援を受けるための診断へ

学校環境の要求水準が高くなっている

✓ 環境要因

- MMRワクチン仮説の否定
- 両親の高齢化 (de novo mutationsの増加)

➤ 主要な原因は遺伝的要因である。

➤ 米国における「華やかな原因探し」と「実際の支援削減」の乖離

Autism is on the rise: what's really behind the increase? RFK Jr has vowed to find out what's responsible, but scientists say he is ignoring decades of research. By Helen Pearson. Nature Vol 644 28 August 2025 **863**

自閉スペクトラム症の原因

➤ 遺伝的要因

双生児研究：一卵性の自閉症で高い一致率（Folstein&Rutter,1977 など）

同胞の危険率が高い（Bolton,1994）

家族構成員に対人関係や言語の障害、常同行為の症状が多い（Piven, Palmor et al.,1997）

脆弱X症候群の問題

➤ 環境要因

高齢出産、低体重出生、胎児期のバルプロ酸暴露（Christensen et al., 2013）

MMRワクチンと自閉スペクトラム症



HHS Public Access

Author manuscript

Annu Rev Virol. Author manuscript; available in PMC 2020 September 29.

Published in final edited form as:

Annu Rev Virol. 2019 September 29; 6(1): 585–600. doi:10.1146/annurev-virology-092818-015515.

The MMR Vaccine and Autism

Frank DeStefano, Tom T. Shimabukuro

Immunization Safety Office, Division of Healthcare Quality Promotion, National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia 30329, USA;

Abstract

Autism is a developmental disability that can cause significant social, communication, and behavioral challenges. A report published in 1998, but subsequently retracted by the journal, suggested that measles, mumps, and rubella (MMR) vaccine causes autism. However, autism is a neurodevelopmental condition that has a strong genetic component with genesis before one year of age, when MMR vaccine is typically administered. Several epidemiologic studies have not found an association between MMR vaccination and autism, including a study that found that MMR vaccine was not associated with an increased risk of autism even among high-risk children whose older siblings had autism. Despite strong evidence of its safety, some parents are still hesitant to accept MMR vaccination of their children. Decreasing acceptance of MMR vaccination has led to outbreaks or resurgence of measles. Health-care providers have a vital role in maintaining confidence in vaccination and preventing suffering, disability, and death from measles and other vaccine-preventable diseases.

いくつかの疫学研究では、MMRワクチン接種と自閉症との関連性は見つかっていない。その中には、MMRワクチン接種は、同胞がASDである高リスクの子どもでもASDリスクの増加と関連がないという研究も含まれている。安全性の強力なエビデンスがあるにもかかわらず、一部の親は依然として、子供へのMMRワクチン接種を躊躇している。

Psychopharmacology

The Rise in Autism and the Mercury Myth

Autism, Asperger's syndrome, and pervasive developmental disorder—not otherwise specified (PDD-NOS) are conditions of early childhood characterized by multiple impairments in socialization and communication, as well as unusual interests and repetitive behavior. The central feature of PDDs is the significant impairment in social development. Differences in communication delay and repetitive behavior distinguish

number of cases per 1,000 or 10,000. Estimating prevalence is all about counting cases. There are three basic approaches in child mental health. The first method tallies all known cases from clinics, private practitioners, hospitals, and schools and uses that figure in the numerator of a prevalence statement. This method is likely to underestimate prevalence because children who have not yet come to a clinic and not been given

Scahill L, Bearss K. The rise in autism and the mercury myth. *J Child Adolesc Psychiatr Nurs.* 2009 Feb;22(1):51-3.

両親の年齢と 自閉症リスク

ORIGINAL ARTICLE

Autism risk associated with parental age and with increasing difference in age between the parents

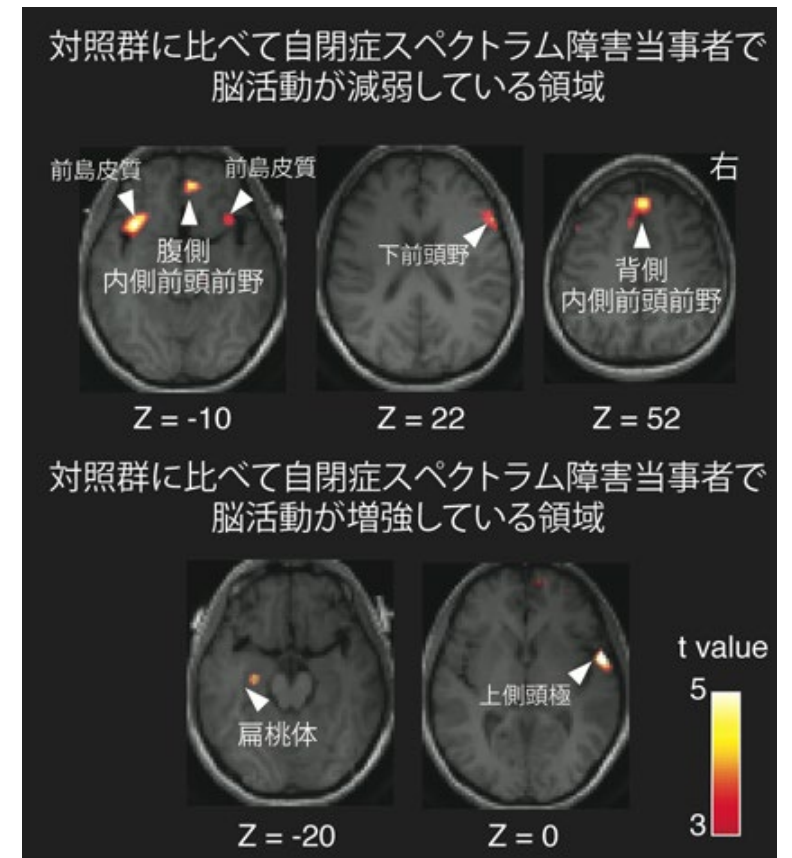
S Sandin^{1,2,3}, D Schendel^{4,5,6}, P Magnusson¹, C Hultman¹, P Surén⁷, E Susser^{8,9}, T Grønberg¹⁰, M Gissler^{11,12,13}, N Gunnes⁷, R Gross^{14,15}, M Henning¹⁶, M Bresnahan^{8,9}, A Sourander¹³, M Hornig^{8,17}, K Carter¹⁸, R Francis¹⁸, E Parner¹⁰, H Leonard¹⁸, M Rosanoff^{8,19}, C Stoltenberg^{7,20} and A Reichenberg^{2,3}

- 1985～2004年に生まれ、2004～2009年末まで追跡調査された5,766,794人の子供を対象とした、5か国（デンマーク、イスラエル、ノルウェー、スウェーデン、西オーストラリア）の人口ベースのコホート研究
- 交絡因子ともう一方の親の年齢を調整した上で、父親と母親の高齢化はそれぞれ ASD の RR の増加と関連していた（母親 40～49 歳 vs 20～29 歳、RR=1.15 95% CI: 1.06～1.24）、P<0.001、父親 ≥50 歳 vs 20～29 歳、RR=1.66 (95% CI: 1.49～1.85)、P<0.001）。
- 母親の年齢が若いことも、ASD のリスク増加と関連していた（母親 <20 歳 vs 20～29 歳、RR=1.18 (95% CI: 1.08～1.29)、P<0.001）。
- 両親の年齢差が大きくなると、母親と父親の年齢と ASD のリスク増加に共同して影響した。ASD の増加は、父親または母親の年齢の上昇だけではなく、両親が若くても年上でも、両親の年齢差も影響した。

自閉スペクトラム症の社会認知障害

ASD当事者では、定型発達者に比べて非言語情報を重視して友好性を判断する機会が有意に少なく、その際に内側前頭前野などの賦活が有意に減弱していた。そして内側前頭前野の賦活が減弱しているほど臨床的なコミュニケーション障害の重症度が高いという相関を認めた。

Watanabe T, et al. Diminished medial prefrontal activity behind autistic social judgments of incongruent information. PLOS ONE 7: e39561, 2012



自閉スペクトラム症の診断基準



A:複数の状況で社会的コミュニケーションおよび対人的相互反応における持続的な欠陥があり、現在または病歴によって、以下により明らかになる。

- (1) 相互の対人的・情緒的関係の欠落
- (2) 対人的相互反応で非言語的コミュニケーション行動を用いることの欠陥
- (3) 人間関係を発展させ、維持し、それを理解することの欠陥

社会的コミュニケーション および相互交渉の異常

➤ 対人的-情緒的関係の欠落

字義通りの解釈。言われたこと以外にはどのようにしたらよいかわからない。
相手の表情が読めない、また自分も感情表出が少ない。

➤ 状況にあった行動の調整が困難。

他者の動きを見て真似することができない。
状況に応じた修正ができない。

➤ 社会性の障害

一般的なルールが理解できず、逸脱した行動をしたり逸脱した要求をする。
社会的常識が身についていない。

自閉スペクトラム症の診断基準

B: 行動、興味、または活動の限定された反復的な様式で、現在または病歴によって、以下の少なくとも2つにより明らかになる。

- (1) 常同的または反復的な身体の運動、物の使用、または会話
- (2) 同一性への固執、習慣への頑ななこだわり、または言語的、非言語的な儀式的行動様式
- (3) 強度または対象において異常なほど、きわめて限定され執着する興味
- (4) 感覚刺激に対する過敏さまたは鈍感さ、または環境の感覚的側面に対する並外れた興味

行動、興味、活動の 限局され反復的な様式

➤ 同一性への固執

変化があるとパニックになってしまう。

➤ 柔軟性に欠ける思考様式

応用が利かない。

➤ 感覚刺激に対する過敏さまたは鈍感さ

人が多いところでは気になってしまってもいけない。

季節感のない服装。

自閉スペクトラム症の診断基準

C: 症状は発達早期に存在していなければならない。(しかし社会的要求が能力の限界を超えるまでは症状は完全に明らかにならないかもしれないし、その後の生活で学んだ対応の仕方によって隠されている場合もある)。

D: その症状は社会的、職業的、または他の重要な領域における現在の機能に臨床的に意味のある障害を引き起こしている。

E: これらの障害は、知的発達症または全般的発達遅延ではうまく説明されない。

自閉スペクトラム症とは

Lorna Wingが提唱した用語。

自閉症と健常との境界ははっきり区別できず連続線上にある。

正常範囲内

自閉スペクトラム症



支援が必要な子ども達

「スペクトラム」の意味するところ

主要な診断的特徴は発達期の中に明らかとなるが、治療的介入、代償、および現在受けている支援によって、少なくともいくつかの状況ではその困難が隠されているかもしれない。

障害の兆候もまた、自閉症状の重症度、発達段階、暦年齢によって大きく変化するので、それゆえに**スペクトラム**という単語で表現される。

自閉スペクトラム症（ASD）の歴史

1943年：カナー 「情緒的接触の自閉性障害」 アメリカ・ボルティモア

自閉的孤立、同一性保持への要求、能力の孤島

1944年 アスペルガー ウィーン

1960年代 概念の拡散と混乱、心因説と統合失調説との格闘

1970年代 自閉症概念の明確化と発達障害説への転換

ラター 英国 言語認知症概説 「言語的コミュニケーションの困難性が、二次的に人との困難性をもたらす」

ウィングとグールド 英国 三つ組み症状 ①対人反応の重大な欠陥、②コミュニケーションの重大な欠陥、③創造的な活動を行うことの重大な欠陥

自閉症スペクトラム障害の概念

高橋脩 自閉症をめぐる医学的概念の変化 こころの科学No.174/3-2014

自閉症の概念の変化

- (1) 狭い定義から広い診断基準へ
- (2) まれな疾患から比較的一般的な疾患へ（女性ではおそらくまだ十分に認識されていない）
- (3) 子どもに影響を与えるものから生涯にわたる疾患へ
- (4) 不連続で明確なものから多角的な見方へ
- (5) 1つのものから多くの「自閉症」、複合的または「分割可能な」疾患へ
- (6) 「純粋な」自閉症に焦点を当てることから、複雑性と併存が標準であるとの認識へ
- (7) 自閉症を純粋に「発達障害」として概念化することから、参加型研究モデルで運用される神経多様性の観点の認識へ

Happé F, Frith U: Annual Research Review: Looking back to look forward - changes in the concept of autism and implications for future research. J Child Psychol Psychiatry 2020, 61(3):218-232.

自閉スペクトラム症の障害仮説

➤ 遂行機能の障害

遂行機能: 目標達成のために適切な問題解決を計画して行う能力

主に前頭葉の機能による

反復行動、全体的統合の弱さ

➤ 特有の情報処理スタイル「システム化」(Baron-Cohen, 2002)

機械的な記憶、特有の認知スタイル

➤ 心の理論 (Baron-Cohen, 1985)

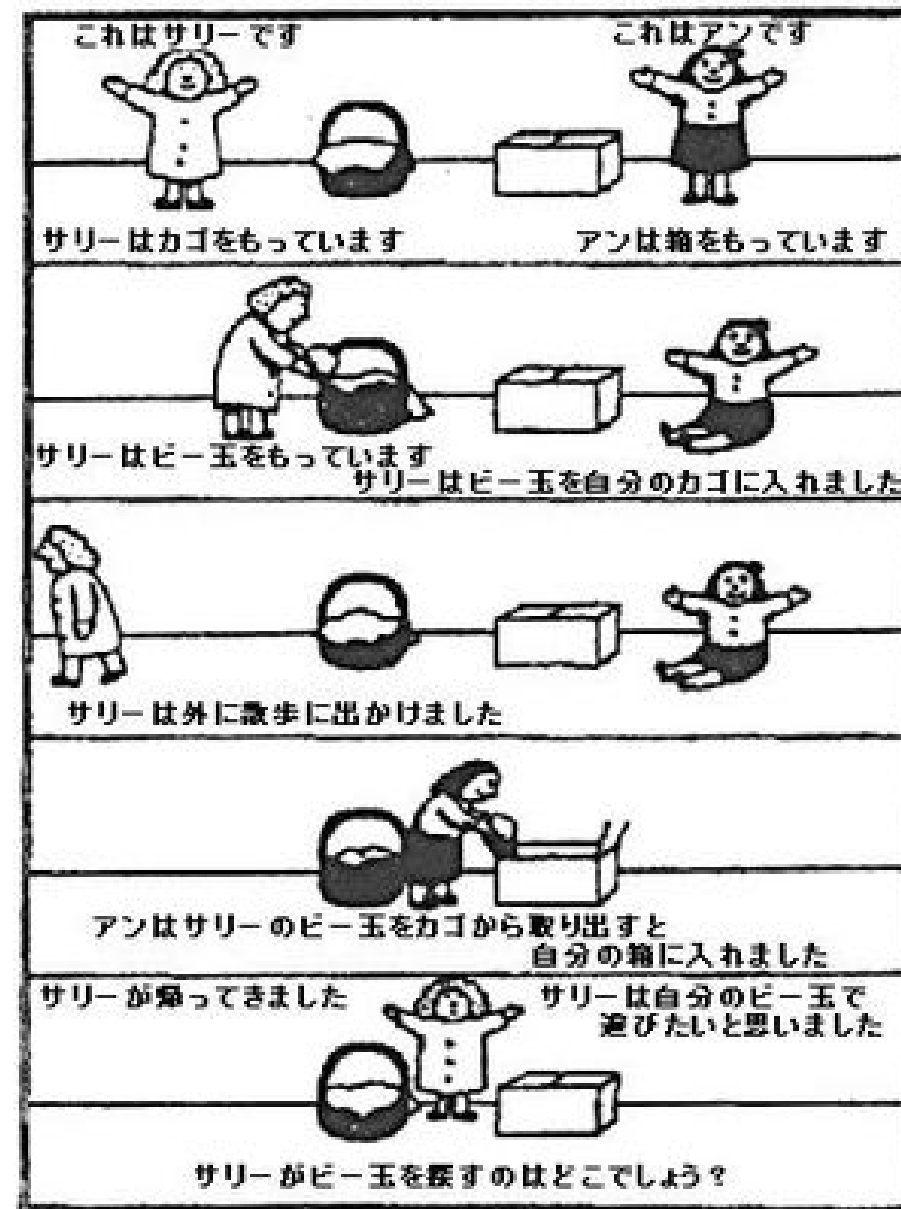
他者の意図や信念を把握する能力

サリー・アン課題など様々な課題

心の理論

サリー・アンの課題

ガイドブック アスペルガー症候群
親と専門家のために
トニー・アトウッド著 東京書籍より



サリーとアンの実験

自閉スペクトラム症の児童思春期の患者の管理とサポート (NICE 臨床ガイドライン 170)

問題行動 (Behavior that challenges)

- ◆ 問題行動のリスクを増大させる要因を評価し、対応する
 - (例) コミュニケーションの障がい、身体疾患および精神疾患、日常環境の変化、思春期の始まり、問題行動の誤った強化など
- ◆ 問題行動のきっかけが特定できない場合、心理社会的介入を最初の治療として提供する
- ◆ 心理社会的介入やその他の治療法が効果不十分な場合、あるいは問題行動の重症度が高くこれら治療法を提供できない場合、**抗精神病薬による治療**を考慮する

抗精神病薬による問題行動の治療*

- ◆ 小児科医または精神科医によって処方される
- ◆ 低用量から始め、最小有効用量を用いる
- ◆ 現在適応外処方であれば適切なインフォームド・コンセントをとる
- ◆ ターゲットとなる問題行動を特定し、有用性と副作用について3-4週間後とその後にモニターする
- ◆ 6週目で臨床的に重要な反応が認められなければ中止する

*抗精神病薬、抗うつ薬、抗てんかん薬は自閉症の中核症状の治療には用いない

自閉スペクトラム症の薬物療法

統合失調症の薬であるリスペリドンとアリピプラゾールが用いられる。
適応は「小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性」とされている。
対症療法であって根本的な治療ではない。
統合失調症よりも少量である。

	統合失調症	自閉スペクトラム症
リスペリドン	2～6mg(最大12mg)	0.25～3mg(体重による)
アリピプラゾール	6～24mg(最大30mg)	1～15mg

自閉スペクトラム症のポイント①

自閉スペクトラム症は**男性**に多い。

自閉スペクトラム症は**しばしば知的発達症を伴う**が、伴わない場合もある。

自閉スペクトラム症は**幼少期に診断される**ことが多いが、大人になってから診断されるケースもある。

①社会的コミュニケーションおよび対人的相互反応における持続的な欠陥、②行動、興味、または活動の限定された反復的な様式、の両症状が、**発達早期に存在**している。

自閉スペクトラム症のポイント②

原因は何らかの**中枢神経系の機能不全**。

躰の失敗が原因ではない。

根本的な治療はなく、療育などで対応

薬物療法はあくまで対症療法。

易刺激性を抑える薬物療法として**リスペリドン、アリピプラゾール**が承認されている。

成人になっても治るわけではない。しかし、成長するので症状は変化する。また周囲の環境によっても変化する。適切な対応が重要。

注意欠如・多動症



注意欠如・多動症 (ADHD)

Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD)

症状：不注意、多動性、衝動性

有病率：子ども約5%、成人約2.5%



※ 2008年6月 日本精神神経学会の「精神神経学用語集改訂6版」でADHDの訳語が「注意欠陥・多動性障害」から「注意欠如・多動性障害」に修正された。DSM-5で「注意欠如・多動症」とも呼ばれるようになった。

注意欠如・多動症(ADHD)

特徴: 混合、多動・衝動性優勢、不注意優勢

カテゴリー: 神経発達障害に分類される。

しばしば幼少期に言葉の遅れがある。

限局性学習症の合併が多い。

自閉スペクトラム症と鑑別が困難な例が多い。

危険要因と予後要因: 気質要因、環境要因、遺伝要因、生理学的要因、経過の修飾要因など

治療: 行動療法、環境調整、家族指導など多面的アプローチ、薬物療法: メチルフェニデート(コンサータ®)、アトモキシチン(ストラテラ®)、グアンファシン(インチュニブ®)、リスデキサンプエタミンメシル酸塩(ビバンセ®)

注意欠如・多動症(ADHD)の歴史

1900年代初頭:「多動性症候群」。衝動で抑制がきかない子ども達。その多くは脳炎による神経学的な障害を持っていた。

1960年代:「微細脳機能障害 Minimal Brain Damage (MBD)」。不器用で学習困難で、情緒的に不安定だが、特定の神経学的な障害はない。軽度の脳波異常が見られることも多い。

ADHD：多動性の一例



小1男子。授業中じっと座っていることができない。つまらなくなると勝手に立ち上がって、教室の後ろの本や教具をいじり出す。注意すると座るが、後ろを向いたり手遊びをしたりし、隣の子に話しかける。家でも、1人で静かに遊ぶことができずに動き回っている。

ADHD：衝動性の一例



小3男子。診察室で医師と母親が話している間、1人で遊べず、「ねえ、これどうやるの?」「見て、見て、できたよ。」と喋りかけてくる。絵合わせゲームをすると、自分の番を続けて2回してしまう。その都度注意すると気付くが、すぐに同じミスを繰り返してしまう。

ADHD: 不注意の一例



小4女子。普段からしょっちゅう忘れ物をし、ランドセルを持たずに登校することがある。一度にいろいろなことをやろうとするため机の上は常にごちゃごちゃになっている。整理整頓ができないことから筆記用具もすぐに失くしてしまふ。宿題に取り掛かっても、すぐに他のことを思い出し、途中でやめてしまって最後までやり遂げられない。

ADHD: 不注意の一例



小5男子。授業中に座ってはいるが窓の外から運動場の声が聞こえるとそちらが気になってしまう。担任教師が注意を向けさせようとして、直接声をかけて話すが、その際も上の空の時間が多く返事が返ってこない。テストではしばしば自分の名前を書き忘れる。家ではゲームばかりやっていて、注意されてもなかなか宿題に取り掛かれない。

DSM-5-TRによるADHDの診断基準

A. (1)および/または(2)によって特徴づけられる、不注意および/または多動-衝動性の持続的な様式で、機能または発達の妨げとなっているもの

(1) **不注意**: 以下の症状のうち6つ(またはそれ以上)が少なくとも6か月持続したことがあり、その程度は発達の水準に不相応で、社会的および学業的/職業的活動に直接、悪影響を及ぼすほどである:

注: それらの症状は、単なる反抗的行動、挑戦、敵意の表れではなく、課題や指示を理解できないことでもない。青年期後期および成人(17歳以上)では、少なくとも5つ以上の症状が必要である。

(a) 学業, 仕事, または他の活動中に、しばしば綿密に注意することができない、または不注意な間違いをする(例: 細部を見過ごしたり、見逃してしまう、作業が不正確である)。

(b) 課題または遊びの活動中に、しばしば注意を持続することが困難である(例: 講義、会話、または長時間の読書に集中し続けることが難しい)。

(c) 直接話しかけられたときに、しばしば聞いていないように見える(例: 明らかな注意を逸らすものがない状況でさえ、心がどこか他所にあるように見える)。

American Psychiatric Association DSM-5-TR 精神疾患の診断・統計マニュアル 医学書院 2023 より

DSM-5-TRによるADHDの診断基準

- (d)しばしば指示に従えず、学業、用事、職場での義務をやり遂げることができない(例:課題を始めるがすぐに集中できなくなる、また容易に脱線する)。
- (e)課題や活動を順序立てることがしばしば困難である(例:一連の課題を遂行することが難しい、資料や持ち物を整理しておくことが難しい、作業が乱雑でまとまりがない、時間の管理が苦手、締め切りを守れない)。
- (f)精神的努力の持続を要する課題(例:学業や宿題、青年期後期および成人では報告書の作成、ような)に従事することをしばしば避ける。嫌う、またはいやいや行う
- (g)課題や活動に必要なもの(例:学校教材、鉛筆、本、道具、財布、鍵、書類、眼鏡、携帯電話)をしばしばなくしてしまう。
- (h)しばしば外的な刺激(例:青年期後期および成人では無関係な考えも含まれる)によってすぐ気が散ってしまう。
- (i)しばしば日々の活動(例:用事を足すこと、お使いをすること、青年期後期および成人では、電話を折り返しかけること、お金の支払い、会合の約束を守ること)で忘れっぽい。

DSM-5-TRによるADHDの診断基準

(2) **多動-衝動性**: 以下の症状のうち6つ(またはそれ以上)が少なくとも6か月持続したことがあり、その程度は発達の水準に不適合で、社会的および学業的/職業的に直接、悪影響を及ぼすほどである:

注: それらの症状は、単なる反抗的行動、挑戦、敵意の表れではなく、課題や指示を理解できないことでもない。青年期後期および成人(17歳以上)では、少なくとも5つ以上の症状が必要である。

- (a) しばしば手足をそわそわと動かしたりとんとん叩いたりする、またはいすの上でもじもじする。
- (b) 席についていることが求めら場面でしばしば席を離れる(例: 教室、職場、他の作業場所で、またはそこにとどまることを要求される他の場面で、自分の場所を離れる)。
- (c) 不適切な状況でしばしば走り回ったり高い所へ登ったりする(注: 青年または成人では、落ち着かない感じの自覚のみに限られるかもしれない)。

American Psychiatric Association DSM-5-TR 精神疾患の診断・統計マニュアル 医学書院 2023 より

DSM-5-TRによるADHDの診断基準

- (d) 静かに遊んだり余暇活動につくことがしばしばできない。
- (e) しばしば「じっとしていない」、またはまるで「エンジンで動かされているように」行動する(例: レストランや会議に長時間とどまることができないかまたは不快に感じる; 他の人達には、落ち着かないとか、一緒にいることが困難と感じられるかもしれない)。
- (f) しばしばしゃべりすぎる。
- (g) しばしば質問が終わる前に出し抜いて答え始めてしまう(例: 他の人達の言葉の続きを言ってしまう; 会話で自分の番を待つことができない)。
- (h) しばしば順番を待つことが困難である(例: 列に並んでいるとき)。
- (i) しばしば他人を妨害し、邪魔する(例: 会話、ゲーム、または活動に干渉する; 相手に聞かずにまたは許可を得ずに他人の物を使い始めるかもしれない; 青年または成人では、他人のしていることに口出ししたり、横取りすることがあるかもしれない)。

DSM-5-TRによるADHDの診断基準

- B** 不注意または多動-衝動性の症状のうちのいくつものが12歳になる前から存在していた。
- C** 不注意または多動-衝動性の症状のうちのいくつものが2つ以上の状況（例：家庭、学校、職場；友人がや親せきという時；他の活動中）において存在する。
- D** これらの症状が、社会的、学業的、または職業的機能を損なわせているまたはその質を低下させているという明確な証拠がある。
- E** その症状は統合失調症、またはほかの精神症の経過中にのみ起こるものではなく、他の精神疾患（例：気分症、不安症、解離症、パーソナリティ症、物質中毒または離脱）ではうまく説明されない。

American Psychiatric Association DSM-5-TR 精神疾患の診断・統計マニュアル 医学書院 2023 より

ADHDが持続するケースの経過

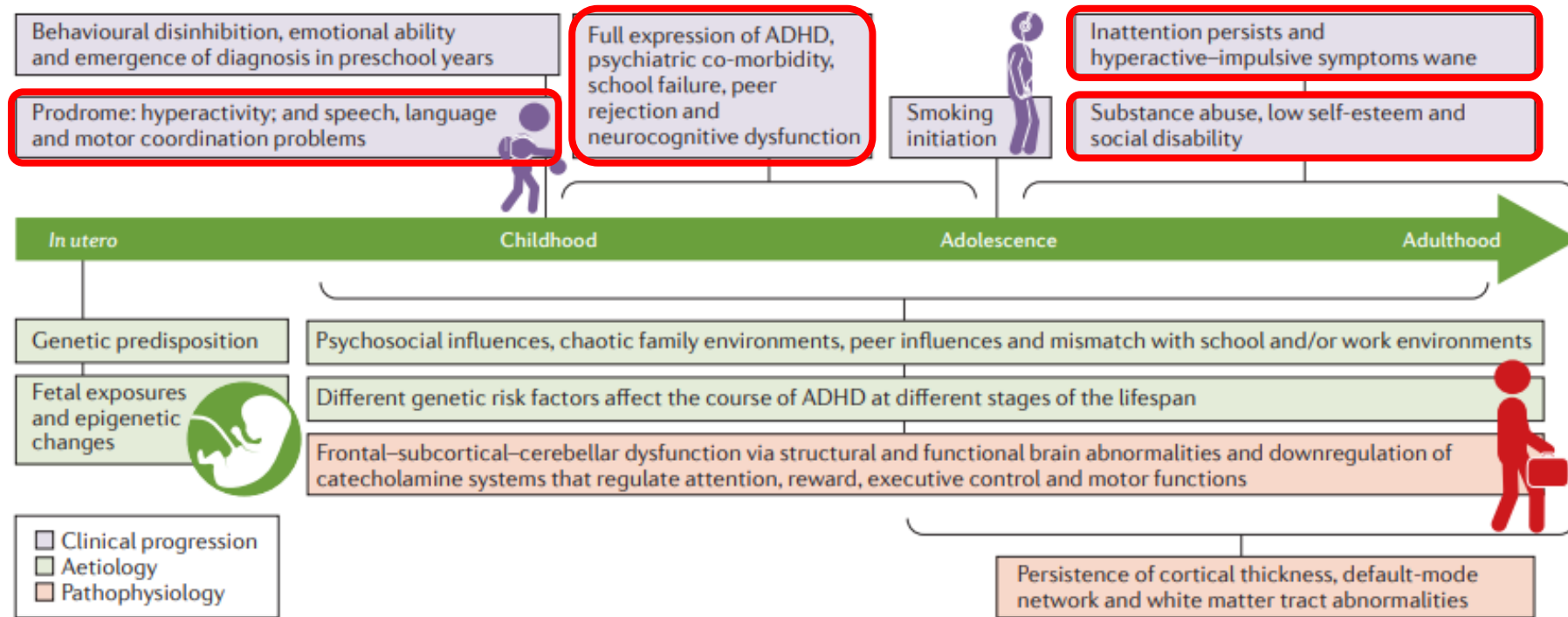


Figure Developmental course of attention-deficit/hyperactivity disorder in persistent cases.

Faraone SV, Asherson P, Banaschewski T et al: Attention-deficit/hyperactivity disorder. Nat Rev Dis Primers, 1:15020, 2015.

大人のADHDの症状

子どものADHDの30～70%が大人になっても続く。大人になって発症するわけではない。

多動性は目立たなくなる。

話の途中で立ち歩くことはなくなる。

衝動性は質を変える。

交通違反、賭博、違法薬物、衝動買い

不注意は持続する。

物事を先延ばしにする、時間の管理ができない、多数のものに手をつけてやり遂げられない、慢性的な挫折感。



ADHDの薬物療法

塩酸メチルフェニデート徐放錠

ADHD適正流通管理システム(<https://www.adhd-vcdcs.jp/>)に登録が必要。医師、医療機関、薬局、調剤責任者の登録が必要

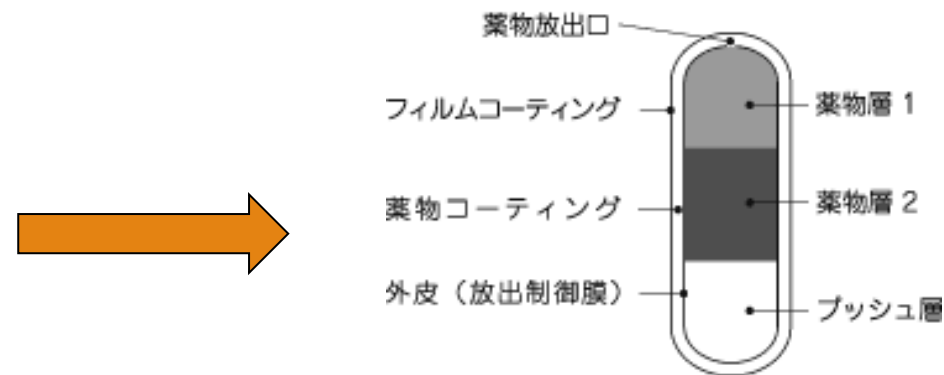
適応年齢: 6歳～(平成25年12月から成人も使用可能になった。)

作用時間: 12時間ほどの作用

カプセル状で少しずつ排出

噛んだり割ったりしてはいけない。

朝飲む: 昼過ぎると夜寝れなくなる。



※ 図はコンサータ錠の添付文書の錠剤断面図より引用

塩酸メチルフェニデート徐放錠

商品名：コンサータ®

副作用：多いのは食欲低下、不眠、頭痛。

しばしば反跳現象：夕方に落ち着きがなくなる。

休日は休薬可能：飲んだ日だけ効果がある。

立ち上がりが緩やかな分、依存は生じにくいとされている。

禁忌：チック

※ 写真は[コンサータ錠18mgの添付文書 - 医薬情報QLifePro](#)より引用



ストラテラ®（塩酸アトモキセチン）

商品名：ストラテラ® SNRIだが抗うつ作用はない

0.5mg/kg→0.8mg/kg→1.2mg/kgと増量し、1.2～1.8mg/kgで維持

適応年齢：6歳以上

（平成24年8月から成人も使用可能になった。）

継続して服用してもらうよう指導する。休薬しない。

継続すれば効果は持続する。

朝夕の2回で家庭で服用できる。（成人は1日1回）



※ 写真は[ストラテラカプセル10mgの添付文書](#) - 医薬情報QLifeProより引用

インチュニブ® (一般名：グアンファシン)

2017年5月26日に発売された。

【作用機序】選択的 $\alpha 2A$ アドレナリン受容体作動薬

【用法・用量】通常，体重50kg未満の小児ではグアンファシンとして1日1 mg、体重50kg以上の小児ではグアンファシンとして1日2 mgより投与を開始し、1週間以上の間隔をあけて1 mgずつ維持用量まで増量する。
1日1回経口投与。

【副作用】傾眠、血圧低下など。

※2019年6月18日より成人への適応が追加された。



※ 写真は[インチュニブ錠1mgの添付文書 - 医薬情報QLifePro](#)より引用

ビバンセ[®]（一般名：リスデキサンフェタミンメシル酸塩）

【作用機序】中枢刺激薬。ドパミンやノルアドレナリンの再取り込み阻害作用に加え、遊離促進作用も持つ。

【用法・用量】1日30mg～70mg。午後の服薬は避ける。

【注意】体内でd-アンフェタミンに変わることから覚せい剤取締法による規制も加わっている。

ADHD流通管理システムで登録。

添付文書には「使用実態下における乱用・依存性に関する評価が行われるまでの間は、**他のADHD治療薬が効果不十分な場合にのみ**使用されるよう必要な措置を講じること」と記載されている。

大人への適応は取得されていない。



※ 写真は[ビバンセカプセル20mgの添付文書](#) - 医薬情報QLifeProより引用

注意欠如・多動症のポイント①

症状は**多動、衝動性、不注意**の3つ。

今出ている症状で多動・衝動優勢、不注意優勢、混合性と特徴を記述する。年齢とともに変化する。

注意欠如・多動症も**男性**に多い。

薬物療法は治療の一部であり、環境調整、心理療法、支援など**多面的な関わり**が重要。

治療薬は**メチルフェニデート徐放剤、アトモキセチン、グアンファシン、リスデキサンフェタミン**が用いられる。

注意欠如・多動症のポイント②

12歳以前から症状があることを確認する。通常は幼少期から症状が認められる。

しばしば自閉スペクトラム症に合併し、診断に迷う症例も少なくない。特異的学習症の合併も少なくない。

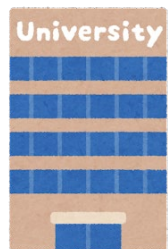
成人になっても症状が続く。特に不注意が持続しやすい。

名古屋市立大学における 神経発達症への医療



こころの発達診療研究センター こころの発達医学寄附講座

令和5年8月1日開設



名古屋市立大学大学院医学系研究科
こころの発達医学寄附講座

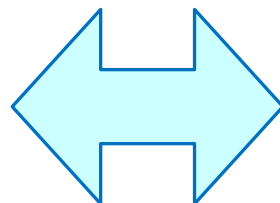


精神科医2名、小児科医2名
臨床心理士・公認心理師2名
プロジェクト推進員1名

R7.10～作業療法士1名
R8.4～臨床心理士1名増員予定



名古屋市立大学病院
こころの発達診療研究センター



名古屋市

子ども青少年局

療育センター
保育所、トワイライトスクール、
学童保育等
発達障害者支援センター

教育委員会

学校、指導室、子ども応援員会
ハートフレンドなごや(教育センター)

健康福祉局

保健センター、こころぼ
障害者就労支援センター

こころの発達診療研究センター

診療体制の構築（診療優先枠の設定など） 専門医の助言・支援
施設等職員に対する研修 心理検査の実施（検査優先枠の設定）



こころの発達医学寄附講座

研究へのフィードバック

出生～就学前

学齢期

青年・成人期



子ども青少年局

療育センター
診療枠の確保



保育所

受入体制の確立、強化
支援体制の充実

教育委員会

学校、指導室
子ども応援委員会

早期発見・問題の未然防止

教育センター
（ハートフレンドなごや）



相談体制の充実、専門性の向上

トワイライトスクール、学童保育
受入体制の確立、強化

健康福祉局

精神保健福祉センター
（こころぼ）

各保健センター
相談体制の充実



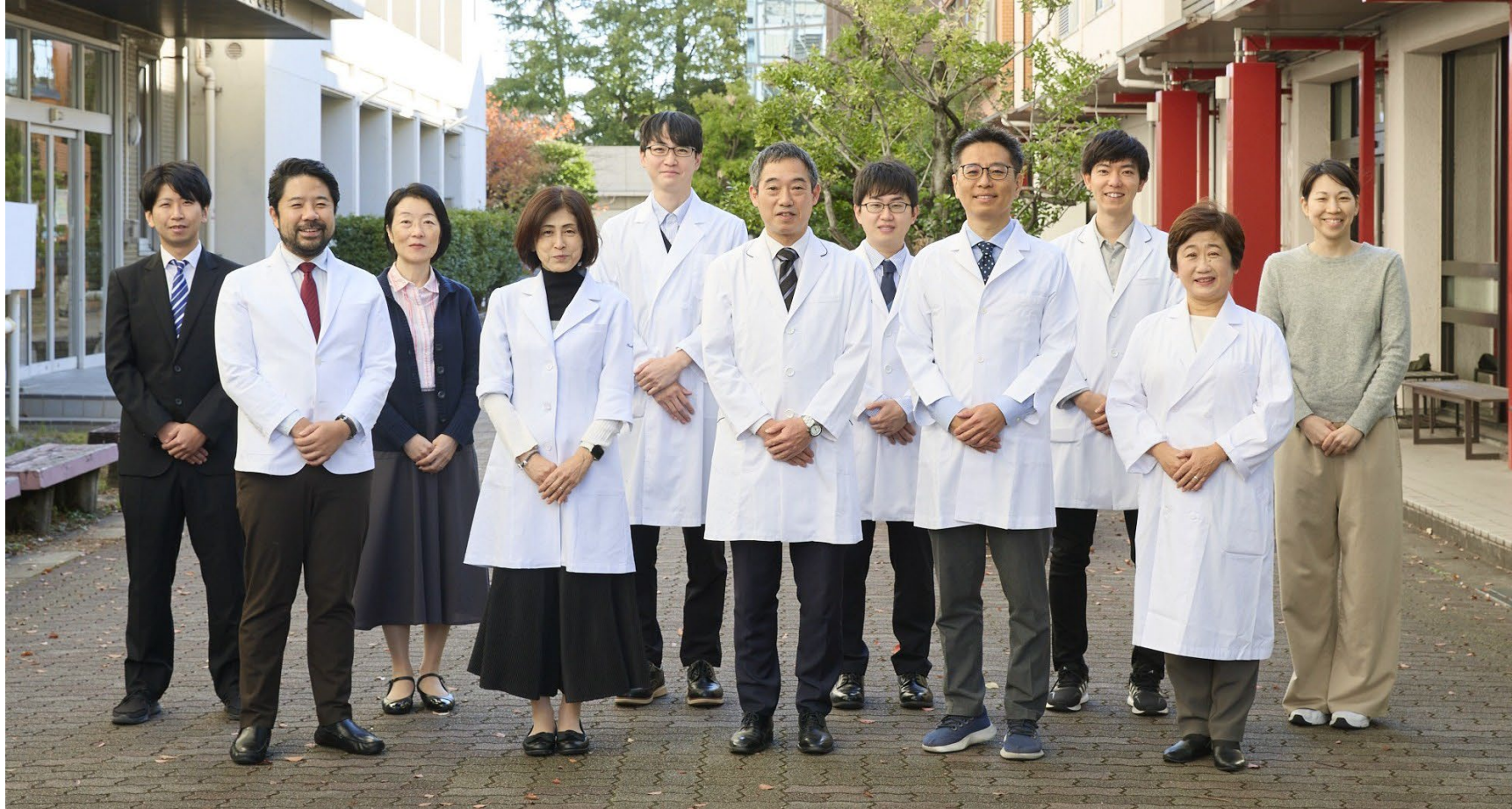
障害者就労支援センター

支援体制の充実

発達障害者支援センター（りんくす名古屋） 支援体制の充実



こころの発達診療研究センター



Home Page



X(@NCU_NDD)



Facebook

